LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 2
Zachman Framework

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:

Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami struktur matriks Zachman (6 x 6) dan memetakan artefak arsitektur Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ke dalam matriks tersebut. Dari pemetaan ini dicari bagian mana yang belum terdokumentasi.

B. Hasil Kerja

Matriks Zachman diisi untuk kelima baris, yaitu Planner, Owner, Designer, Builder, dan Implementer. Isian didasarkan pada kondisi Dinas Kesehatan Cianjur yang sudah dijelaskan di Modul 1. Matriks lengkap (Tabel 2.2) ada di halaman berikutnya. Status tiap sel diberi warna dengan keterangan berikut.

- Hijau: artefak sudah ada.
- Kuning: artefak ada sebagian.
- Merah: artefak belum ada.

Alasan pemberian status warna:

- Hijau: tujuan strategis, daftar unit organisasi, dan rencana bisnis sudah ada di dokumen perencanaan dinas (Renstra) dan struktur organisasi.
- Kuning: SOP pelayanan sudah ada, tetapi belum digambar sebagai model proses. Daftar lokasi dan kalender pelaporan juga baru ada sebagian.
- Merah: model data, diagram jaringan, rancangan antarmuka antar aplikasi, skema basis data terpadu, dan jadwal backup belum pernah dibuat.
- Baris Builder dan Implementer: aplikasi dan server sudah berjalan sehingga banyak yang kuning atau hijau, tetapi dokumentasi teknis dan pengaturan terpusatnya belum ada.

Tabel 2.2 Matriks Zachman Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Perspektif	**What**	**Who**	**Where**	**Who**	**When**	**Why**
Planner	Daftar data utama: pasien, Puskesmas, tenaga kesehatan, obat, program kesehatan, peserta Jamkesda	Daftar proses inti: pelayanan Puskesmas, pelaporan program, pengelolaan obat, monitoring stunting	Daftar lokasi: kantor Dinkes, Puskesmas, Posyandu, gudang farmasi	Daftar unit: Kepala Dinas, bidang, Puskesmas, Diskominfo	Jadwal pelaporan bulanan dan triwulan, jadwal imunisasi	Visi, misi, dan 4 tujuan strategis
Owner	Model hubungan antar data (pasien, kunjungan, diagnosis) belum ada	SOP pelayanan ada, model proses (BPMN) belum ada	Alur kerja antara Dinkes, Puskesmas, dan gudang farmasi belum digambar	Pembagian tugas antar unit ada, tetapi belum rinci (belum ada RACI)	Jadwal induk pelaporan dan program ada, belum terpadu	Renstra, RKA/DPA, dan indikator SPM
Designer	Model data logis belum ada, format data belum seragam	Aplikasi (SIMPUS, obat, Jamkesda) berjalan sendiri-sendiri, dokumentasi kurang	Diagram jaringan dan sebaran sistem belum ada	Rancangan antarmuka (SSO, API, hak akses) belum ada	Jadwal sinkronisasi data ke SATUSEHAT belum ada	Aturan Kemenkes dipahami, belum dijadikan aturan sistem
Builder	Skema basis data fisik terpadu belum ada, tiap aplikasi punya basis data sendiri	Spesifikasi teknis tiap aplikasi ada dari vendor, belum ada untuk integrasi	Konfigurasi server dan jaringan antar lokasi belum didokumentasikan	Desain tampilan login dan hak akses pengguna terpadu belum ada	Jadwal teknis backup dan sinkronisasi data belum ada	Standar keamanan dasar ada, belum ada aturan teknis tertulis
Implementer	Data pasien dan program tersimpan di aplikasi dan file Excel masing-masing	Aplikasi SIMPUS, inventaris obat, dan pelaporan Jamkesda sudah berjalan	Server dan komputer di dinas dan Puskesmas ada, tetapi kondisinya berbeda-beda	Akun petugas ada di tiap aplikasi, belum terpusat	Jadwal input dan laporan rutin berjalan, backup belum terjadwal	Target kinerja sistem (waktu pelaporan, ketersediaan) belum ditetapkan

Keterangan warna: hijau = sudah ada, kuning = sebagian, merah = belum

C. Analisis dan Pembahasan

Dari matriks terlihat bahwa baris Planner dan Owner sudah cukup banyak terisi (hijau dan kuning), sedangkan baris Designer dan Builder banyak yang merah. Baris Implementer lebih terisi karena aplikasinya memang sudah dipakai sehari-hari, tetapi berjalan tanpa rancangan yang terpadu. Artinya dinas sudah punya tujuan dan rencana, tetapi belum punya rancangan sistem yang menjalankannya. Tiga sel yang paling penting menurut saya adalah sebagai berikut.

1. Designer x What (model data logis). Pada Modul 1 ditemukan bahwa format data di Puskesmas belum sesuai standar nasional. Tanpa model data yang seragam, data pasien dan imunisasi sulit dikirim ke SATUSEHAT, dan tujuan satu sumber data (Single Source of Truth) tidak bisa tercapai. Sel ini saya anggap paling utama karena menjadi dasar integrasi.

2. Designer x Who (rancangan antarmuka). Aplikasi pendaftaran, obat, dan Jamkesda belum terhubung dan belum ada SSO. Akibatnya petugas harus input data dua kali dan membuka banyak akun. Tujuan integrasi ke SATUSEHAT juga sulit berjalan kalau antarmukanya belum dirancang.

3. Designer x Where (diagram jaringan dan sebaran sistem). Jaringan di Puskesmas daerah pelosok terbatas dan belum ada backup terpusat otomatis. Tanpa diagram, sulit menentukan kebutuhan jaringan dan lokasi server, sehingga pelaporan real-time berisiko gagal dan data bisa hilang.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Karena Zachman hanya mengelompokkan artefak arsitektur ke dalam matriks berdasarkan enam pertanyaan (What, How, Where, Who, When, Why) dan enam perspektif. Zachman tidak memberi langkah kerja atau urutan cara membuat artefak tersebut. Jadi Zachman memberi tahu apa yang perlu ada, bukan bagaimana membuatnya.

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Zachman tidak punya proses atau tahapan seperti siklus ADM pada TOGAF. Zachman juga tidak membantu menentukan prioritas, gap analysis, roadmap, maupun tata kelola. Dengan Zachman kita bisa tahu sel mana yang kosong, tetapi tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. TOGAF melengkapinya dengan metode bertahap dan panduan pembuatan artefak.

E. Kesimpulan

Matriks Zachman membantu melihat dokumen arsitektur apa saja yang sudah dan belum dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Bagian yang paling kosong ada di perspektif Designer, terutama model data, rancangan antarmuka, dan diagram jaringan. Bagian ini perlu dikerjakan pada modul-modul berikutnya agar tujuan integrasi dan pelaporan otomatis ke SATUSEHAT dapat tercapai.

F. Lampiran

Tidak ada berkas model pada modul ini.